

基礎研 レポート

特別国会で成立した医療保険制度 改革法で何が変わるのか？

OTC 類似薬や高額療養費の見直しなどを規定、今後の適正化策も考える

保険研究部 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 三原 岳
(03)3512-1798 mihara@nli-research.co.jp

1——はじめに～特別国会で成立した医療保険制度改革法で何が変わるのか～

2026 年特別国会に提出されていた医療保険制度改革法が同年 6 月、与党などの賛成多数で可決、成立した。この法律では、最近の国政選挙で話題になっている「現役世代の社会保険料軽減」に向け、市販薬（いわゆる OTC 薬、Over The Counter）と同じ効能などを持つ「OTC 類似薬」の給付見直しが盛り込まれたほか、患者負担を抑制する「高額療養費」の見直し、出産費用の保険適用、75 歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度における金融所得の反映なども規定された。その後、高額療養費の限度額を引き上げる政令が改正され、2026 年 8 月から施行された。

本稿では、それぞれの見直し項目に関する内容や経緯を考察するとともに、今後の論点を検討する。特に OTC 類似薬の見直しに関しては、患者に「特別の料金」を課す際、「一部保険外療養」という新たな仕組みが作られた点に着目する。つまり、これまでは患者の選択に基づいて「特別の料金」を徴収する「選定療養」による見直しが多かったのに対し、OTC 類似薬の見直しについては、別の仕組みが作られた意味合いに着目する。

さらに、高額療養費の見直しについては、2025 年通常国会で是非を巡って紛糾した経緯を振り返りつつ、2026 年特別国会での審議が総じて「無風」になった背景なども検討する。その上で、与党内で進む医療費適正化の論議を概観し、今後の方向性を展望する。

2——医療保険制度改革法の概要

今回の医療保険制度改革法に関して、厚生労働省が公表している概要資料は図表 1 の通りである¹。近年の傾向として、幾つかの関連事項が 1 本の法律としてまとめられる通称、「東ね法案」として処理されることが多く、図表 1 の内容が一括して 2026 年特別国会で審議された。その主な内容としては、

(1) より公平な負担の実現、効率的な給付の確保、(2) 出産等の次世代支援や現役世代からの予防・健康づくりの拡充、(3) 必要な医療の提供の確保、(4) その他——で整理されており、国会審議で論

¹ 本稿の執筆に際しては、『朝日新聞』『共同通信』『日本経済新聞』『読売新聞』の記事に加えて、『医薬経済』『国保実務』『社会保険旬報』『週刊社会保障』『m3.com』などの専門誌も参考にした。なお、引用部分の元号は全て西暦で統一した。

争となった OTC 類似薬の見直しは (1)、高額療養費の見直しは (3) に位置付けられている。

本稿では、▽OTC 類似薬の見直し、▽高額療養費の見直し、▽出産費用の保険適用、▽後期高齢者医療制度における金融所得の反映、▽その他——の順で整理しつつ、経緯や論点を検討するとともに、今後の方向性を展望する。その際には、社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）医療保険部会が 2025 年 12 月に示した「議論の整理」など、今回の法改正のベースとなった政策文書も必要に応じて参照する。

その上で、後半では社会保険料の抑制を重視する日本維新の会（以下、維新）の連立政権入りに伴い、与党内で進む医療費適正化策の内容とか、予算編成の「前哨戦」として 2026 年 7 月に決まった「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太方針）の文言などにも言及する。

図表1：医療保険制度改革法の概要

健康保険法等の一部を改正する法律案の概要	
改正の趣旨	持続可能な医療保険制度の実現に向けて、必要な保険給付等の適切な実施と世代間や世代内での負担の公平性の確保を図るため、一部保険外療養の創設、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組等に係る措置を講ずる。
改正の概要	1. より公平な負担の実現、効率的な給付の確保【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】 ① OTC医薬品と代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、薬剤費の一部を保険給付外とする一部保険外療養を創設する。 ② 後期高齢者医療において、上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映するため、金融所得の支払に係る報告書等（法定調書）を金融機関等がオンラインにより後期高齢者医療広域連合へ提出する義務等を設ける。 2. 出産等の次世代支援や現役世代からの予防・健康づくりの拡充【健保法、船員保険法、国保法、母子保健法等】 ① 出産に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し等を行う。 ② 妊婦健診に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、妊婦健診（望ましい基準内）の実施に係る標準額を定める等の環境の整備をするほか、サービス及び費用の見える化を進める。※こども家庭庁所管事項 ③ 国民健康保険制度において、子どもに係る均等割保険料（税）の 5 割を軽減する措置の対象を、未就学児から高校生年代まで拡充する。 ④ 現役世代の予防・健康づくりを強化するため、全国健康保険協会が取り組む保健事業に関する責務を明確化する。 3. 必要な医療の提供の確保【健保法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法等】 ① 高額療養費の支給要件等を定める際には、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化する。 ② 業務効率化・勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する新たな事業を地域医療介護総合確保基金に設けるほか、計画を作成し業務効率化・勤務環境改善を推進する病院を厚生労働大臣が認定する仕組みを設ける。併せて、医療機関は業務効率化・勤務環境改善に努めるものとする。 4. その他【健保法、国保法、高確法等】 ① 全国健康保険協会の平均保険料率の引き下げとあわせ、令和 8 年度から令和 10 年度までの時限措置として、全国健康保険協会への国庫補助に係る特例減額の控除額を引き上げる特例措置を講じる。 ② 国民健康保険組合に対する国庫補助について、一定の場合に、現行の補助率の下限よりも低い補助率を例外的に適用する。 ③ 国民健康保険の財政安定化基金（本体基金分）について、納付金（保険料）の抑制のための取崩しを認める。等
施行期日	このほか、平成 19 年の雇用保険法等の一部改正法で改正を要した船員保険法第 76 条第 6 項について、規定の形式的修正を行う。 令和 9 年 4 月 1 日（ただし、2 ④及び 4 ①は公布日、3 ①は令和 8 年 8 月 1 日、3 ②の一部は令和 9 年 1 月 1 日、1 ①は公布後 1 年以内に政令で定める日、2 ①及び ②は公布後 2 年以内に政令で定める日、1 ②は公布後 5 年以内に政令で定める日等）

出典：厚生労働省資料から抜粋

3——OTC 類似薬の見直し

1 | OTC 類似薬の見直し論議が浮上した経過

まず、OTC 類似薬の見直しを取り上げる²。ここで言う OTC 類似薬とは、一般に市販されている薬と似た成分の薬などを指す。これを保険適用から外したり、適用範囲を狭めたりした上で、薬局などで

² OTC 類似薬見直しに関しては、土屋敦司ほか（2026）「OTC 類似薬の保険給付見直しに関する議論の経緯と論点」日本総合研究所未来社会価値研究所、印南一路（2025）「OTC 類似薬の保険適用除外」『週刊社会保障』2025 年 11 月 17 日号、村上正泰（2025）「OTC 類似薬の保険適用除外提案について」『医薬経済』2025 年 5 月 15 日号などを参照。

医師の処方箋がなくても購入できる市販薬にシフトさせれば、患者にとっては、薬局などで薬を買う時の負担が増える半面、全体として保険給付を抑制できる効果を期待できる。このため、維新は2025年2月に示した「社会保険料を下げる改革案（たたき台）」で、「国民医療費 45 兆円のうち OTC 類似薬は 2.3%の約 1 兆円」とした上で、先行的な見直しを求めている。

こうした維新の主張が医療制度改革の論点として注目されたのは政局の影響だった。当時の与党だった自民、公明両党は2024年10月の総選挙で衆院の過半数を失っていたため、2025年度予算の衆院通過に際して、維新との連携を深め、3党は2025年2月、OTC 類似薬の見直しを含めた社会保障改革の協議体を設置することで一致した。

さらに、3党は同年3月に発足した協議体で議論を進め、同年6月の3党合意では OTC 類似薬に関して、「医療の質やアクセスの確保、患者の利便性を考慮しつつ、医療保険制度の持続可能性確保を目指すことを基本とし、2025 年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについては、2026 年度から実行する」という一文が盛り込まれた。その後、公明党の連立離脱や高市早苗政権の発足などの政治変動が起きたが、入れ替わるように維新が連立与党に入ったため、OTC 類似薬の見直し論議は政府・与党内で絶えず進められた。

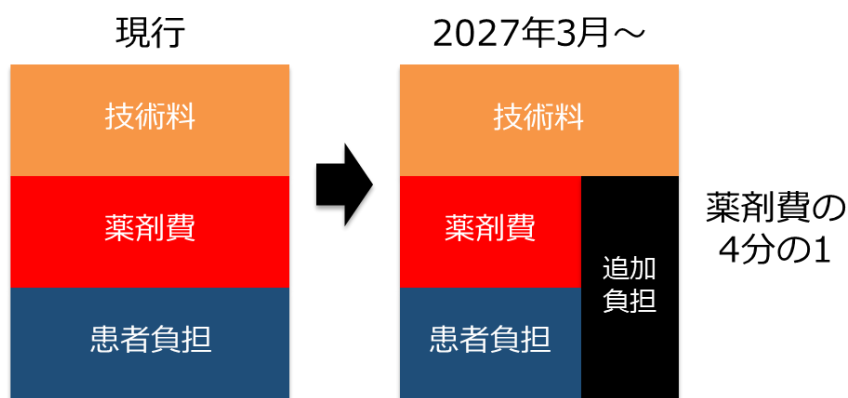
しかし、医療保険部会では患者団体から「公的な保険給付から外れてしまいますと、（略）およそ数十倍という相当程度の過重な負担増となる可能性があります」³という意見が示された。最終的に、OTC 類似薬を保険給付の対象から外すのではなく、「特別の料金」という形で患者に追加負担を課すことが決まり、2025 年 12 月に交わされた自民、維新の政調会長合意で決着した。

2 | 制度改革の内容

次に、OTC 類似薬の見直しに関する今回の制度改革の内容を検討する。今回の制度改革では、鼻炎、胃痛、痛み止め、肩こり、風邪症状などの日常的な医療に用いる医薬品の一部について、薬剤費の 4 分の 1 を「特別の料金」として、追加的に患者負担を徴収することが決まった。

そのイメージは図表 2 の通

図表2：OTC類似薬の一部保険外療養のイメージ



出典：厚生労働省資料を基に作成
注：患者負担は年齢などで異なる。

りであり、対象医薬品は 77 成分、約 1,100 品目。厚生労働省は「OTC 医薬品と成分・投与経路が同一で、かつ一日の最大用量が異ならないといった医療用医薬品を機械的に選定した」と説明している⁴。具体的な品目としては、解熱鎮痛薬のロキソニンや抗アレルギー薬のアレグラ、便秘薬のマグミット

³ 2025 年 11 月 20 日、医療保険部会議事録における全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長による発言を参照。以下、肩書は全て当時で統一。

⁴ 2025 年 12 月 25 日、医療保険部会議事録における厚生労働省保険局の姫野泰啓総務課長による発言を参照。

などが該当する（77成分の詳細は末尾の参考資料を参照）。

これによる給付抑制額は900億円程度と説明されており、国民医療費の負担内訳をベースに機械的に試算すると、国費（国の税金）ベースで約230億円、被保険者の本人負担保険料は250億円程度の抑制になる見通しだ。施行は2027年3月の予定。

3 | 先例は長期収載品見直し

こうした見直しの先例になったのが長期収載品の見直しである。ここで言う長期収載品とは、一般的に後発医薬品（いわゆるジェネリック医薬品）が普及している医薬品を指しており、保険給付の圧縮とともに、医薬品メーカーの技術革新を促すため、2024年10月から新たな仕組みが始まった⁵。

具体的には、ジェネリック医薬品が普及している先発医薬品のうち、上市后5年経過または後発医薬品の置き換えが50%以上となった医薬品を使った場合、保険給付の範囲が縮小され、後発医薬品の最高価格帯との差の4分の3に限定される代わりに、患者から「特別の料金」を追加的に徴収することになった。

要するに、価格の差額の4分の1を「特別の料金」として患者負担に上乗せする見直しであり、今回の先例になったのは間違いない。この点については、「規定ぶりについて選定療養などを参考にした」という政府サイドの国会答弁と符合する⁶。

なお、長期収載品に関する「特別の料金」については、2026年10月から「2分の1」に引き上げられることになっている。

4 | 「一部保険外療養」を創設

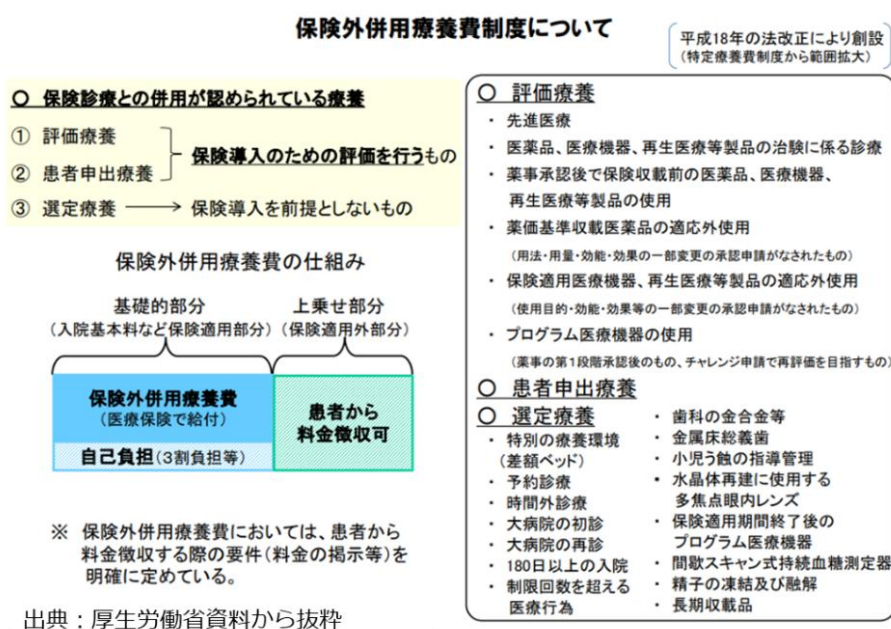
しかし、先例となった長期収載品の見直しと比べた大きな違いとして新たな類型が作られた点を指摘できる。

ここでは保険給付と保険外給付を組み合わせる「保険外併用療養費制度」が絡むので、この仕組みから説明を試みる。

保険外併用療養費制度は2006年医療制度改革で作られた仕組みであり、いわゆる「混合診療」として知られ

る。つまり、原則は医療保険の給付に関して、保険外の先端医療などを組み合わせると、原則として

図表3：保険外療養費制度のイメージ



⁵ 長期収載品の見直しについては、2026年3月5日拙稿「[2026年度の社会保障予算を分析する](#)」、2024年9月11日拙稿「[2024年度トリプル改定を読み解く\(下\)](#)」を参照。

⁶ 2026年5月26日、第221回国会参院厚生労働委員会議事録における厚生労働省の間隆一郎保険局長による発言。

全額が自己負担になる仕組みだが、保険外併用療養費制度は保険と保険外の組み合わせが例外的に認められている。

これは図表 3 の通り、▽評価療養、▽患者申出療養、▽選定療養——に区分けされており、前の 2 つは保険適用に向けて評価する仕組み、後者は保険導入を前提としない違いがある。

このうち、1 つ目の評価療養とは将来的に保険給付の対象とするかどうか評価することが必要な医療と整理されている。例えば先進医療や治験に関する診療、薬事承認後で保険収載前の医薬品などの使用、病気の診断や治療などを目的としたデジタル機器である「プログラム医療機器」の使用などが対象となっている。

2 つ目の患者申出療養とは、国内で承認されていない医薬品を早く使いたいという患者の要望に沿うため、2016 年度改正で作られた仕組み。例えば、患者が「日本では実施されていないけど、海外では治療法があるみたいなので、自分にも使えるような可能性を探りたい」という申出を起点にし、安全性や有効性などを確認しつつ、必要な医療を提供できるようにする枠組みである。

3 つ目の選定療養とは、将来的な保険導入を前提としておらず、患者の「選定」で保険外の診療と保険診療を併用する仕組み。例えば、医療機関の差額ベッドや歯科の金合金、紹介状なし大病院の初診・再診⁷などであり、先に触れた長期収載品も選定療養に含まれる。分かりやすく言うと、「中小病院や診療所で紹介状をもらえば安く済むのに、いきなり大病院で受診したい」「安価なジェネリックが普及しているのに、それでも長期収載品を使いたい」という患者の「選定」に対し、特別の料金を課すという考え方である。

これに対し、今回の法改正では保険外併用療養費制度に「一部保険外療養」という仕組みが作られた。具体的には、医療用医薬品から転用された新薬など安全性に関する調査期間中の市販薬を意味する「要指導医薬品」、または一般医薬品との代替性に着目しつつ、「特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの」と定められた。

このように新しい類型を作った判断について、必ずしも政府は明示的に説明していないが、選定療養では患者の「選定」、つまり患者の同意が大前提となっていたのに対し、OTC 類似薬では患者が「選定」できる場面は少ない。このため、わざわざ選定療養と異なる仕組みを作ることになったと推察される。

実際、医療保険部会では「(筆者注：これまでの選定療養は) アメニティ的部分、まさに選定、選択といったことでこういう制度ができて」「OTC 類似薬の場合は、少なくとも現状、保険診療の中での話でありますので、(略) 公平性という意図でこういう部分を制度化するとすれば、果たして既存の選定療養の範囲に入るのかどうか」といった意見が出ていた⁸。

つまり、患者から見ると、受診前に医療機関で OTC 類似薬の処方箋を受け取るか、薬局で市販薬を買うか、選択する場面はあるものの、医療サービスを受ける際の選択とは言えないため、選定療養と

⁷ 医療機関の機能分化に向けて、2016 年度以降、紹介状など大病院受診について追加の料金を取るようになった。その後、「大病院」の対象が 200 床以上の医療機関などに拡大したほか、追加負担額も当初の 5,000 円から 7,000 円に引き上げられた、2022 年 10 月 25 日拙稿「[紹介状なし大病院受診追加負担の狙いと今後の論点を考える](#)」を参照。さらに、茨城県など一部の自治体が軽度患者の救急車の利用についても、「特別の料金」を課している。

⁸ 2025 年 12 月 25 日医療保険部会議事録における国際医療福祉大学の伊奈川秀和教授による発言を参照。

は別の枠組みで保険給付を圧縮したことになる。

だが、新しい枠組みを作った結果として、今後に向けて幾つかの論点が残された。以下、(1)「特別の料金」を課さない対象者の選定、(2)「特別の料金」が4分の1から引き上げられる可能性、(3)「特別の料金」がその他の領域に波及する可能性、(4) その他——などに分けて検討する。

5 | 今後の論点(1)～「特別の料金」を課さない対象者の選定～

まず、「特別の料金」を課さない対象の線引きである。2025年12月の自民、維新政調会長合意や厚生労働相と財務相の折衝事項、医療保険部会の議論の整理など、一連の文書を見ると、こども、がん患者、難病患者など慢性疾患の患者、低所得者、入院患者など、長期使用が医療的に必要な対象者が例示される形で、配慮の必要性が言及されている。

つまり、OTC 類似薬の薬剤費のうち、4分の1を「特別の料金」を課す一方で、配慮が必要な患者については、「特別の料金」の対象外とすることが決まっており、その線引きが論点になっているわけだ。

こうした論点を詰めるため、厚生労働省は2026年5月、「OTC 類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会（以下、技術的検討会）」を設置。今後、「医療用医薬品と OTC 医薬品の効能効果がどの範囲で一致し、どの範囲が異なるか」といった点も含めて、制度の詳細に関して、2026年8月以降に結論を出すとしている。

6 | 今後の論点(2)～「特別の料金」が4分の1から引き上げられる可能性～

次に、「特別の料金」が4分の1から引き上げられる可能性であり、これには幾つかの「傍証」が見受けられる。例えば、先行例となった長期収載品を巡る「特別の料金」は2026年10月以降、当初の4分の1が2分の1に引き上げられることになっており、OTC 類似薬でも同様の展開を辿る可能性を示唆しているように感じられる。

さらに、2025年12月の自民、維新政調会長合意も有力な「傍証」になり得る。合意文を見ると、「特別の料金をいただく薬剤費の割合の引き上げについても検討」という文言が入っているためだ。

実際、この点は国会論戦で問題になった。つまり、対象外となる比率が引き上げられた結果、最終的に100%、つまり全額を自己負担にした場合、国民皆保険の理念に反するのではないか、という指摘である。

こうした指摘に対し、厚生労働省は「現時点で別途の負担を薬剤の全額とするということは考えていません」⁹と答弁したが、あくまでも答弁では「現時点」と説明されており、今後の見直し論議で引き上げの是非が焦点になる可能性がある。

7 | 今後の論点(3)～「特別の料金」の対象が拡大する可能性～

第3に、「特別の料金」の対象がその他の領域に広がる可能性であり、ここでも2025年12月の自民、維新政調会長合意が検討の素材となる。つまり、77成分、約1,100品目を対象にすると定めた文章の前に「まず」という一言が盛り込まれているほか、「対象範囲を拡大することを目指し…」という

⁹ 2026年4月24日、第221回国会衆院厚生労働委員会議事録における上野賢一郎厚生労働相の発言。

一文が入っており、「特別の料金」が課される対象が広がる可能性も示唆されている。2026 年 7 月に閣議決定された骨太方針でも、「OTC 類似薬の保険給付の見直しの施行とその状況等を踏まえた 2027 年度以降の対象範囲の拡大に向けた検討」という一文が入っている。

さらに、対象が拡大する可能性は国会論戦で話題になった。つまり、野党から改正健康保険法の「特に高い薬剤を用いた療養その他の～」という条文について、「一部保険外療養の対象を OTC 類似薬の薬剤費以外に対象を広げるのではないか」という指摘が出たのである。

これに対し、厚生労働省が「規定ぶりとしてはそのように読めるかもしれませんが」¹⁰と述べる一幕もあった。最終的に「現時点で、OTC 類似薬以外について、一部保険外療養として別途の負担を求めることは想定しておりません」¹¹という答弁で決着した。衆参両院の厚生労働委員会の附帯決議でも「薬剤以外の診療行為を含めるべきではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること」という文言が入った。

しかし、国会答弁では「現時点」という言葉が使われており、今後の見直し論議では焦点になり得ると言える。中でも、近年の自民、維新の合意文や過去の政策文書を見ると、「民間保険の活用」という文言が繰り返し入っている¹²ため、対象が拡大する可能性を意識する必要があるようだ。

8 | 今後の論点(4)～その他～

このほかにも「セルフメディケーション税制」の拡充が関係する。これは 2016 年度税制改正で作られた仕組みであり、医療用医薬品を市販薬に切り替えた医薬品（いわゆる「スイッチ OTC」）の購入額が 1 万 2,000 円を超える時、超える部分の金額（上限は 8 万 8,000 円）について、その年の総所得金額から控除できる。今後、一部保険外療養の適用となる薬品の対象範囲が広がったり、特別の料金が上乘せされたりした場合、負担軽減策の一環として、セルフメディケーション税制の見直しが浮上する可能性が想定される。

さらに、薬局や薬剤師の対人支援業務の強化も絡む可能性がある。このテーマについては、2015 年

¹⁰ 2026 年 4 月 15 日、第 221 回国会衆院厚生労働委員会議事録における上野厚生労働相の発言。

¹¹ 2026 年 4 月 15 日、第 221 回国会衆院厚生労働委員会議事録における厚生労働省の間保険局長による発言。

¹² ここでは詳しく触れないが、最近の政策資料で「民間保険の活用」が言及された始まりは 2025 年 6 月の骨太方針と「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」改訂版である。このうち、前者では「保険外併用療養費制度の対象範囲の拡大や保険外診療部分を広くカバーし、公的保険を補完する民間保険の開発を促す」という文言が入り、後者でも「有効性評価が十分でない最先端医療等（再生医療等製品、がん遺伝子パネル検査等）について、国民皆保険の堅持とイノベーションの推進を両立させつつ、希望する患者が保険診療の対象となるまで待つことなく利用できるよう、保険診療と保険外診療の併用を認める保険外併用療養費制度の対象範囲を拡大する」「一定の質が確保された自由診療を対象とする民間保険が近年誕生しており、一定の評価を得ていることも踏まえ、患者の負担軽減・円滑なアクセス確保の観点から、民間保険会社による多様な商品開発が一層促進されるよう、保険外診療部分を広くカバーし、公的保険を補完する民間保険の開発を推進していく。有効性評価が十分に求められる公的保険の手前の段階として民間保険に委ねられる分野に関する共通理解を醸成するため、保険外併用療養費制度等の各種制度に関する基本理解（プリンシプル）について、民間保険会社等と対話を深めることを通じ、民間保険会社等による自主的な商品開発の取組を促していく」という文章が盛り込まれた。さらに 2025 年 10 月に交わされた自民、維新の連立政権樹立に関する合意文で、「国民皆保険制度の中核を守るための公的保険の在り方及び民間保険の活用に関する検討」という方向性が示されたほか、両党がまとめた 2026 年 7 月の社会保障改革に関する文書でも「国民皆保険制度の理念を堅持しつつ、高度化・高額化する医療へのアクセスを確保するため、公的保険と民間保険の役割分担を検討する」「公的保険を補完する民間保険の活用可能性、先進医療等の対象拡大、民間保険による補完が有効な領域（一部保険外療養と民間保険の相互補完を含む）、利用者保護の在り方について財務省、厚労省、金融庁を含む関係省庁で検討を行う」「公的保険を補完する民間保険の活用について、生命保険業界及び損害保険業界等を含む有識者の意見を聴取し、検討を行う」という文言も入った。

10月の「患者のための薬局ビジョン」を境に盛んに論じられており、OTC 類似薬の見直し論議と関係する可能性がある¹³。

つまり、OTC 類似薬に関する保険適用の範囲が縮小すると、患者は医療機関や薬局に行くか、それとも OTC で対応するか判断を求められることになる。その結果、薬局などで薬の効能や服薬方法、副作用などを説明する薬剤師による助言が重要になる。

次に、OTC 類似薬の見直しと同様、国会で論戦になった高額療養費の見直し論議を巡る経緯や論点を取り上げる。

4——高額療養費の見直し

1 | 高額療養費の上限引き上げ

高額療養費とは、1カ月の窓口負担を原則として8万円程度に抑える仕組み。年齢や所得で上限が異なるが、70歳未満の場合、2026年7月までの所得区分は「年収約1,160万円～」「年収約770～約1,160万円」「年収約370～約770万円」「～年収約370万円」「住民税非課税者」という5つの区分だった。

図表4：高額療養費に関する見直し案

現在の 年収区分	現在の 月額上限	現在の外来特例の 月額上限	2027年8月 以降の年収区分	2027年8月 以降の月額上限	2027年8月 以降の年間上限	2027年8月以降の 外来特例の月額上限
約1,160万円～	25万2,600円+1% <14万100円>	——	約1,650万円～	34万2,000円+1% <14万100円>	168万円	——
約770万円～ 約1,160万円	16万7,400円+1% <9万3,000円>	——	約1,410万円～ 約1,650万円	30万3,000円+1% <14万100円>	168万円	——
約370万円～ 約770万円	8万100円+1% <4万4,400円>	——	約1,160万円～ 約1,410万円	27万300円+1% <14万100円>	168万円	——
～約370万円	5万7,600円 <4万4,400円>	1万8,000円 (年14万4,000円)	約1,040万円～ 約1,160万円	20万9,400円+1% <9万3,000円>	110万円	——
70歳未満 住民税非課税	3万5,400円 <2万4,600円>	——	約950万円～ 約1,040万円	19万9,400円+1% <9万3,000円>	110万円	——
70歳以上 住民税非課税	2万4,600円	8,000円	約770万円～ 約950万円	17万9,100円+1% <9万3,000円>	110万円	——
70歳以上 一定所得以下	1万5,000円	8,000円	約650万円～ 約770万円	11万400円+1% <4万4,400円>	53万円	——
			約510万円～ 約650万円	9万8,100円+1% <4万4,400円>	53万円	——
			約370万円～ 約510万円	8万5,800円+1% <4万4,400円>	53万円	——
			約260万円～ 約370万円	6万9,600円+1% <4万4,400円>	53万円	2万8,000円 (年21万6,000円)
			約200万円～ 約260万円	6万5,400円+1% <4万4,400円>	53万円	2万8,000円 (年21万6,000円)
			～約200万円	6万1,500円+1% <3万4,500円>	41万円	2万2,000円 (年21万6,000円)
			70歳未満 住民税非課税	3万6,900円 <2万4,600円>	29万円	——
			70歳以上 住民税非課税	2万5,700円 <2万4,600円>	29万円	1万3,000円 (年9万6,000円)
			70歳以上 一定所得以下	1万5,700円	18万円	8,000円
2026年8月 以降の年収区分	2026年8月 以降の月額上限	2026年8月 以降の年間上限	2026年8月以降の 外来特例の月額上限			
約1,160万円～	27万300円+1% <14万100円>	168万円	——			
約770万円～ 約1,160万円	17万9,100円+1% <9万3,000円>	110万円	——			
約370万円～ 約770万円	8万5,800円+1% <4万4,400円>	53万円	——			
～約370万円	6万1,500円 <4万4,400円>	53万円 (※)	2万2,000円 (年21万6,000円)			
70歳未満 住民税非課税	3万6,900円 <2万4,600円>	29万円	——			
70歳以上 住民税非課税	2万5,700円 <2万4,600円>	29万円	1万1,000円 (年9万6,000円)			
70歳以上 一定所得以下	1万5,700円	18万円	8,000円			

出典：厚生労働省資料を基に作成
注1：<>の金額は多数回該当の上限。
注2：「※」の～200万円区分は年上限41万円を適用、2027年8月から償還払い。

しかし、図表4のような見直しが2026年8月以降、段階的に進められることになった。つまり、高

¹³ 2026年度調剤報酬の見直しでは、医療機関の近くで処方箋を受け付ける「門前薬局」の報酬が大幅に引き下げられた。詳細は2026年6月22日拙稿「[2026年度診療報酬改定を読み解く（上）](#)」を参照。対人シフトに関する経緯などについては、2021年10月15日拙稿「[かかりつけ薬剤師・薬局はどこまで医療現場を変えるか](#)」を参照。

所得者の上限を高く設定する「応能負担」を強化しつつ、▽2026年8月から2段階で引き上げ、▽住民税非課税世帯などを除き、現在の4区分を12区分に変更、▽年間単位で合算できる仕組みを創設、▽所得の低い階層の上げ幅を抑制、▽長期療養の患者を対象とした「多数回該当」は据え置き——といった内容が盛り込まれた。

一方、70歳以上を対象とする外来特例についても引き上げる反面、所得が一定以下では8,000円で据え置かれることになった。

上記の見直しを実行するための関係政令が改正されており、第1弾の引き上げは2026年8月から始まった。

2 | 2025年通常国会での白紙撤回

こうした案が決まるまで紆余曲折を経た。特に、2025年通常国会では、政府案に対して国会の内外で批判が高まり、当初案が3度も修正される異例の事態に発展した。この時の経緯は今回の意思決定に影響を及ぼしているので、簡単に経過を補足する¹⁴。

元々、高額療養費の見直し論議は「次元の異なる少子化対策」の財源確保から始まった。つまり、当時の岸田文雄政権が少子化対策を決定する際、「国民負担を増やさない」という方針を繰り返し示したため、総額3.6兆円程度に及ぶ財源を既存予算の見直しや歳出カットで捻出することになった。その際、歳出改革のメニューなどを並べた「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」が策定され、ここに高額療養費の上限引き上げが言及されていた。つまり、高額療養費の上限見直しを通じて患者負担を増やすことで、保険料や国・自治体の公費（税金）の負担を抑制することが企図されていたわけだ。

その後、高額療養費の見直し論議は2024年10月頃から本格化し、2025年度当初予算編成で見直し案が一旦、決まった。この案では2025年8月以降、3段階で高額療養費の上限の引き上げが企図されており、見直しに伴う給付費ベースの抑制額は最終的に5,300億円程度と見られていた。

しかし、上限の引き上げ幅が急だった上、患者団体の意見を聞かなかったプロセスなどが批判された。特に、多数回該当も大幅に引き上げる案だったため、患者団体が猛反発した。

結局、見直しに伴う国費（国の税金）の削減額を盛り込んでいた2025年度当初予算が3度も修正を受ける異例の事態に発展し、政府は同年3月、事実上の白紙撤回を決めた。その後、厚生労働省は同年5月、医療保険部会に「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」（以下、専門委員会）を設置し、患者団体の意見を聞きつつ、見直し論議を再開させた。結局、同年12月にまとめた見直し案で

¹⁴ 2025年通常国会での論争以後、高額療養費の書籍や論考は数多く公表されている。ここでは白紙撤回後に発表された主な書籍や論文、論考として、二木立（2026）『ファクトで展望する高齢日本の医療政策』勁草書房、西村章（2026）『高額療養費制度』集英社新書を参照。さらに、安藤道人ほか（2025）「高額療養費改革案はどう見送られたのか」『医療経済研究』37巻1号のほか、安藤道人（2025）「高額療養費の負担限度額引き上げ案はどう『拙速』だったのか」『都市問題』2025年8月号、同「高額療養費上限額引き上げ案の衝撃と教訓」『社会保険旬報』2025年6月1日号、五十嵐中（2026）「高額療養費と『破滅的医療費支出、所得減少』の影響」『医薬経済』2026年4月1日号、同（2026）「高額療養費見直し、残された『破滅的』問題」『医薬経済』2026年2月1日号、同（2025）「高額療養費15万人の分析、『破滅的医療費支出』の実態」『医薬経済』2025年12月1日号、同（2025）「高額療養費と破滅的医療費支出」『医薬経済』2025年8月1日号、同「『8.4万人が適用対象外』高額療養費の影響分析」『医薬経済』2025年4月1日号、李忻（2026）「高額療養費制度の近年の制度改革の意義と課題」『週刊社会保障』2026年2月23日号なども参照。2025年4月10日拙稿「[異例づくめの高額療養費の見直し論議を検証する](#)」も参照。

は図表 4 の通り、昨年案よりも全体的に引き上げ幅を抑えるなど、配慮が講じられた。

その結果、2026 年度当初予算での給付抑制額は国費（国の税金）ベースで 300 億円程度、最終的な給付費の抑制額は計 2,450 億円になると見られている。2025 年度当初予算に盛り込まれていた案の給付抑制額が約 5,300 億円だったことを考えると、約半分になった形だ。

3 | 2026 年特別国会での法律改正事項

ここで注目されるのは法律の改正事項である。本来、高額療養費の上限は政令に委任されており、法改正が要らない。元々、2025 年度予算編成に際して、先行的に高額療養費の見直しが選ばれた理由の一つも国会情勢だった。つまり、当時の与党が衆院で過半数を失っている中、国会審議を経なくても制度改正に踏み切れるという判断である。それでも高額療養費の見直しに伴う国費（国の税金）の抑制が 2025 年度予算に盛り込まれていたため、2025 年通常国会で焦点になった。

今回の上限引き上げについても、基本は政令事項であり、特別国会で成立した医療保険制度改革法に盛り込まれているわけではない。新たに創設された年間上限という類型についても、政令に委任されている。このため、2026 年度予算が同年 4 月に成立した時点で、図表 4 の見直しは実行されることが決まっていた。

今回の法律の改正事項としても、詳細を政令に委任する根拠の条文で、特に長期療養者の家計への影響を適切に考慮する必要性が明確にされた程度である¹⁵。ここが「高額療養費の支給要件を定めるに当たって、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上、明確化すること」としております。条文に書いております」という政府の説明の部分¹⁶であり、2024～2025 年の見直し論議が紛糾した経緯に加えて、2025 年 4 月の衆院厚生労働委員会の附帯決議¹⁷で同様の表現が盛り込まれていたことが影響していると考えられる。

4 | 紛糾した昨年と比べると…

今回の見直しが確定するまでの過程では、2025 年通常国会と同様、上限引き上げの妥当性が論点になった。特に、検討過程で話題になった概念が「破滅的医療支出」(Catastrophic Health Expenditure) である¹⁸。これは 2025 年 2 月頃から言われ始めた概念であり、世界保健機関 (WHO) などの定義によると、収入から税金や保険料、食費などの生活費を除いた「支払い能力」に対し、医療費の支出が一定程度を超える状況を指すとされている。

¹⁵ 具体的には、健康保険法第 115 条 2 の「療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める」という条文が改正され、「家計」の後に「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」という一文が加えられた。

¹⁶ 2026 年 4 月 24 日、第 221 回国会衆院厚生労働委員会における高市早苗首相による発言を参照。

¹⁷ この時の附帯決議では、2025 年通常国会で見直し論議が紛糾したことを受けて、「働きながらがんの治療を受ける患者など、長期にわたって高額な医療費のかかる患者が適切な自己負担額で高額療養費制度を利用できるよう、今後の制度変更は以下の考慮と手続を経た上で行うこと」とした上で、「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意すること」「政令を定める前に、審議会へ委員として参加を認めるなど、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者その他関係者の意見を聴くこと」を政府に促していた。2025 年 4 月 16 日、第 217 回国会衆院厚生労働委員会議事録を参照。

¹⁸ 管見の限り、2025 年 2 月に開かれたセミナーで五十嵐中・東京大学大学院特任准教授が言及したのが始まりと思われる。同月 20 日『m3.com』配信記事などを参照。国会では 2025 年 3 月の予算委員会で話題になった。2025 年 3 月 3 日、第 217 回国会衆院予算委員会議事録を参照。

仕切り直しされた見直し論議でも患者団体が専門委員会の席上、様々なデータを示しつつ、「特に低所得の方を中心に、既に破滅的医療費支出に該当している方々が一定程度いらっしゃるということが想像できる」と主張する一幕があった¹⁹。

さらに国会審議でも、この言葉が何度も言及されたほか、中道改革連合などの野党が対案として、患者の家計に与える影響を実態調査するように政府に促す法案を衆院に提出した際にも、この言葉が説明で使用された²⁰。

しかし、政府提出の予算や法律は原案通り解決されており、紛糾した 2025 年の国会審議と比べると、大きな「波乱」は起きなかった。このように結果的に「無風」になった理由の第 1 として、国会情勢の変化を指摘できる。つまり、2025 年通常国会の審議では少数与党の下、政府・与党は野党の意見を取り入れる必要に迫られていたが、2026 年 2 月の総選挙で与党が圧勝したことで、政府・与党のペースで審議が進みやすい環境になった。

第 2 に、前回の案が白紙撤回に追い込まれたことで、厚生労働省が慎重な手続きを取った点も影響していると思われる。例えば、前回の案では患者団体の意見を聞かなかったことが反対意見を増幅させる結果を招いたが、今回は患者団体の意見を聴取する機会を専門委員会で設けた。さらに、専門委員会でも「40 歳代男性、年収約 410 万円、胃がん患者、胃がん・内視鏡手術」「40 歳代女性、年収約 450 万円、乳がん・切除術＋再建術」といった形で、医療費や患者負担の変化を複数のパターンの試算が公表された。

このほか、2025 年度の検討過程では見直し案が 2024 年 12 月に公表された後、医療保険部会が 1 カ月近く開かれなかったが、今回は図表 4 の内容が確定した直後に医療保険部会が開催された。以上のような経過を踏まえると、少なくとも前回の案よりも検討過程が積み重ねられたことは間違いないだろう。

第 3 に、白紙撤回された案よりも引き上げ幅を抑えたり、長期療養の患者を対象から外したりするなど、反発を避ける手立てを取った点である。年間上限の新設という前向きなメッセージを示したことも反対意見を和らげる効果を持ったと思われる。

しかし、患者、特に医療費を多く支出する患者に対して負担を求める点は変わらない事実であり、今後も家計支出や受療行動に及ぼす影響を注視する必要がある。さらに国会論戦では、転職や転居などで加入している保険者（保険制度の運営者）が変わると、多数回該当の回数がリセットされる問題も指摘されており、制度の改善も意識する必要がある。

次に、今回の医療保険制度改革法に盛り込まれた事項として、出産費用の保険適用を取り上げる。こちらも少子化対策の一環として浮上した経緯があり、議論の経過や論点を整理する。

5——出産費用の保険適用

1 | 出産費用の保険適用を巡る議論

今回の医療保険制度改革法では、出産費用を保険適用とするため、健康保険法などに「分娩費」と

¹⁹ 2025 年 11 月 21 日、高額療養費制度の在り方に関する専門委員会議事録における全国がん患者団体連合会の天野理事長による発言を参照。

²⁰ 2026 年 4 月 20 日、『立憲民主党ニュース』を参照。

いう類型が追加されるとともに、分娩1件当たりの基本単価が設定されることになった。さらに、それぞれの保険者から分娩取扱施設にダイレクトに給付されることになり、妊産婦の窓口負担は発生しない仕組みが取られることになった。併せて、出産費用の保険適用に伴って、50万円が支給されている「出産育児一時金」の廃止も決まった。

今回の制度改正の背景を理解する上では、出産費用を巡る動向を踏まえる必要がある。そもそも現行制度では「通常の病気やケガと異なる」という判断の下、正常分娩は自由診療、異常分娩は保険診療という区分けになっており、前者の正常分娩については、出産費用を手当てするため、出産育児一時金が支給されている。こうした「正常分娩は自由診療＋手当」「異常分娩は保険診療」という区分は制度改変を挟みつつ、一貫した立て付けとなっている。

このうち、出産育児一時金は少子化対策の一環として、段階的に引き上げられており、2023年4月以降、原則42万円から50万円に引き上げられた。

しかし、出産育児一時金の引き上げに向けた検討が進む傍らで、早くも一層の制度改正として、保険適用の是非が論点として浮上していた。出産費用は年々、上昇しており、「出産育児一時金を引き上げれば、便乗的に出産費用も上がってしまうのでは」という懸念が出たためである²¹。

さらに、岸田内閣が重視した「次元の異なる少子化対策」の一環としても、出産費用の低減が論点になり、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」では、2026年度をメドに、「出産費用（正常分娩）の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める」という文言が盛り込まれていた。

こうした経緯を踏まえ、厚生労働省は2024年6月、「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」を設置し、出産費用の保険適用を含めた広範なテーマを議論した。その後、同年12月に示された「議論の整理」では、標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計について、2026年度をメドに進める方向性が提示された。

さらに、2025年12月に公表された医療保険部会の議論の整理では、出産費用の上昇や施設間の格差を踏まえつつ、「現行の出産育児一時金という給付方式では必ずしもその目的が十分に達せられなくなりつつある」との問題意識が示され、全国一律の水準で現物を給付する見直しが必要との認識が強調された。その上で、具体的な方策として、「出産独自の給付類型を設けた上で、妊婦に負担を求めず、設定した費用の10割を保険給付とするべき」という考え方も強調された。

つまり、分娩1件当たりの基本単価を設定した上で、現物給付に切り替えるとともに、設定した費用は全て保険給付とすることで、妊産婦に患者負担を求めない考え方であり、今回の法改正に反映された。

2 | 制度の一斉移行は困難

しかし、少し分かりにくい決着となった面は否めない。つまり、出産費用が保険適用され、現物給付に切り替わるものの、保険給付に移行するかどうか、施設の実情に応じて判断してもらうとされて

²¹ 出産育児一時金の引き上げから出産費用の保険適用に至る議論の経過については、2023年6月27日拙稿「[「出産育児一時金の制度改正で何が変わるのか？」](#)」を参照。

いる。さらに、施設単位では現金給付の仕組みを残すという方針も示されている。

これは 2022 年度診療報酬改定から保険適用された不妊治療と異なる展開となった。つまり、この時には菅義偉首相の意向を踏まえて、それまで国や自治体の補助金で支援されていた不妊治療が保険適用となり、全国一斉で切り替わった²²が、今回の出産費用の保険適用では、施設単位で判断できる余地や現金給付の仕組みが残された。

このように分かりにくい決着となった背景を理解する上では、制度改正に際して、▽周産期の医療提供体制が影響を受ける、▽妊婦の負担増に繋がる——といった懸念が示されたことを踏まえる必要がある。以下、2 つの点に絞りつつ、制度改正の論点を整理する。

3 | 出産費用の保険適用を巡る論点

第 1 に、周産期の医療提供体制に及ぼす影響である。つまり、正常分娩は自由診療で対応されており、医療機関が自由に値段を決めているため、地域や施設ごとに価格差が非常に大きい。こうした状況で保険適用となる標準的な出産費用について、平均額（2024 年度上半期で約 52 万円）を参照しつつ、保険適用の単価を全国一律に設定した場合、一部の医療機関の収入が下がり、経営危機と医療機関へのアクセス悪化を招くリスクが指摘されている。

つまり、「妊産婦に対する経済的支援の強化→医療機関の経営危機→妊産婦のアクセス悪化」という状態が生まれた場合、施策の効果が失われることになりかねないという懸念である。実際、日本医師会（以下、日医）など診療側からは「制度設計によって分娩施設等を含めた地域の提供体制が運営できなくなると、身近で分娩する施設がなくなってしまう」²³、「（筆者注：周産期医療体制は値付け次第で）地域によっては崩壊する可能性がある」²⁴との懸念が示されている。関係学会からも「標準的な分娩には 75 万円ほど必要になってくる」との声が出ている²⁵。

このため、医療保険部会の議論の整理では「安全で質の高い周産期医療提供体制の確保を進める中、妊産婦の経済的負担の軽減策が地域の周産期医療提供体制の確保に影響を与えないようにすることは、検討の前提」としつつ、「妊産婦に対する経済的支援」「周産期医療提供体制の確保」の両立を図る必要性が言及されている。

第 2 に、出産育児一時金の廃止に伴って、妊産婦の負担が増える可能性である。つまり、実際の費用が出産育児一時金を下回った場合、差額は妊婦に支給されるため、様々な費用に充てることができた。一方、新しい仕組みの場合、出産費用が医療保険でカバーされたとしても、出産育児一時金が廃止されると、現金を受け取れなくなるため、結果的に負担が増える可能性があるというわけだ。

こうした事情を踏まえ、医療保険部会の議論の整理では、「新たな給付体系において、分娩 1 件当たりの基本単価とは別に、全ての妊婦を対象とした現金給付を設けることが適当」との考え方が示され

²² 不妊治療の保険適用を巡る経緯については、2022 年 5 月 16 日拙稿「[2022 年度診療報酬改定を読み解く（上）](#)」を参照。

²³ 2026 年 6 月 18 日、社会保障審議会医療保険部会における日本医師会の城守国斗常任理事による発言。2026 年 7 月 1 日『社会保険旬報』No. 3004 を参照。

²⁴ 2026 年 6 月 18 日、社会保障審議会医療保険部会における日本病院会の島弘志副会長による発言。2026 年 7 月 1 日『社会保険旬報』No. 3004 を参照。

²⁵ 2026 年 4 月 8 日に開かれた記者懇談会における日本産婦人科医会の石渡勇会長による発言。同月 10 日『m3.com』配信記事を参照。

た。さらに、当分の間は施設単位で現金給付の仕組みも残しつつ、「可能な施設から新制度に移行していくことが適当」という考え方も提示された。

ただ、医療機関の経営や妊産婦への影響を最小限にしようとする、当然にして保険給付は増える方向に働き、健康保険組合連合会（以下、健保連）などが難色を示す可能性がある。実際、健保連は新たな給付体系への移行に際して、医療保険財政や保険料負担への影響に考慮する必要性に言及²⁶しており、分娩1件当たりの単価設定を含めて、詳細な制度設計に向けて調整の難航も予想される。

次に、今回の医療保険制度改革法に盛り込まれた見直し項目の論点として、後期高齢者医療制度における金融所得の反映を取り上げる。

6——後期高齢者における金融所得の反映

ここでは金融所得を巡る不公平感の解消が意図されている。つまり、現在の仕組みでは、確定申告の場合には課税所得と扱われるため、保険料や窓口負担の算定などで「所得」として勘案されるものの、確定申告を経ずに源泉徴収で課税が終了する場合には課税所得に含まれず、保険料や窓口負担の算定などに勘案されない。このため、医療保険部会の議論の整理では「不公平な取扱い」になっている現状が問題視された。

一方、市町村の税情報が活用されているのは後期高齢者医療制度と国民健康保険であり、医療保険部会の議論の整理では「国民健康保険は賃金をベースに保険料等を賦課する被用者保険とのバランスや地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のスケジュールに留意する必要がある」とし、手始めに後期高齢者医療制度から導入する考え方が示されていた。施行は「公布後5年以内」と定められている。

このほか、今回の医療保険制度改革法には、幾つか注目される改正項目が入っている。以下、その他の改正項目として、▽協会けんぽ向け国庫負担の特例的な削減、▽国民健康保険の子どもに関する負担軽減、▽医療機関の生産性向上支援に関する見直し——の順番で内容を概観する。

7——その他の改正項目

1 | 協会けんぽの国庫負担削減

協会けんぽは主に中小企業の従業員と家族が加入する保険者であり、近年は賃上げや適用拡大を受けて財政状況が好転している。具体的には、2025年度現在の準備残高は過去最高の6兆5,457億円にまで積み上がっている。そこで、協会けんぽに対する国庫補助金を特例的に差し引く「特例減額」の枠組みが強化されることが決まった。

この見直しを理解する上では、協会けんぽに関する制度改正の経緯をたどる必要がある。元々、協会けんぽの医療給付費に対する国庫補助金は民主党政権期の2010年度に13.0%から16.4%に引き上げられた。その後、2015年改正健康保険法では国庫補助率が「当分の間」、16.4%と規定された半面、準備金残高が積み上がる場合、剰余金（単年度収支差の黒字分）の国庫補助相当額を減額する仕組み

²⁶ 2026年6月18日、社会保障審議会医療保険部会における健康保険組合連合会の米川孝・副会長による発言。2026年7月1日『社会保険旬報』No. 3004を参照。

が設けられた。

さらに、今回の見直しに至る 2026 年度当初予算に関する大臣折衝では、剰余金がプラスとなった翌年度の 2011 年度から 2014 年度までの間、特例減額が実施されていたと仮定した場合、約 1,500 億円の国費（国の税金）が浮いていた計算になるとして、2028 年度までの 3 年間で毎年 500 億円ずつ控除額に上乗せすることが決まった²⁷。

このほか、協会けんぽに関しては、健康づくり事業に関する責務が条文で明確化された。すなわち、協会けんぽを運営する全国健康保険協会が被保険者や家族の事情を考慮しつつ、適切かつ有効に保健事業を実施するとともに、その状況を厚生労働省に報告する義務規定が改正健康保険法に規定された。

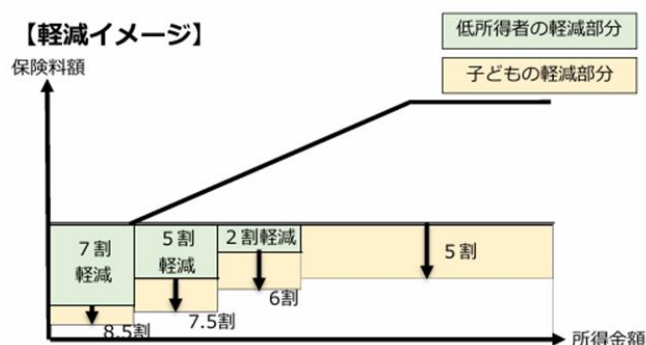
2 | 国民健康保険の子どもに関する均等割の負担軽減

さらに、自営業などを対象とする国民健康保険について、子どもを対象にした保険料の軽減措置が拡充された。これは子育て世帯の負担軽減を企図した見直しであり、見直し内容の検討に入る前に、国民健康保険料の仕組みを簡単に説明する。

国民健康保険料²⁸の決定に際しては、所得や資産など支払い能力に応じた「所得割」「資産割」のほか、世帯の被保険者数に応じて増える「均等割」、1 つの世帯ごとに定額で課される「平等割」という方法が使われており、4 つ全てを組み合わせる「4 方式」、資産割を除く 3 つで保険料を設定する「3 方式」、所得割と均等割で保険料を課す「2 方式」から市町村の判断で決められる。

このうち、均等割では子どもの人数が多い世帯ほど保険料が高くなるため、図表 5 の通り、2022 年度から国・自治体の公費（税金）による負担を通じて、未就学児に関する保険料が半額に軽減されていた。今回の医療保険制度改革法では、18 歳になる年度の高校生年代まで減免対象が拡大された。

図表5：国民健康保険の子どもに関わる保険料負担軽減のイメージ



出典：厚生労働省資料から抜粋

さらに、国民健康保険の関係では、保険料の年間上限額（賦課限度額）を 2026 年度から 1 万円引き上げて 110 万円とすることも決まった。引き上げは 2022 年度から 5 年連続。

このほか、都道府県単位に設置されている国民健康保険の「財政安定化基金」について、取り崩しのルールが見直された。こ

れは市町村単位の保険料負担が急激に増加しないように調整する仕組みであり、2018 年度改正で創設された。具体的には、市町村が予期せぬ資金不足などに直面した場合、財政安定化基金から資金を借り、原則として 3 年間で財政安定化基金に戻すことが義務付けられている。

²⁷ 2026 年度から全国平均の保険料を平均 10%から平均 9.9%に引き下げることが決まっている。ただ、協会けんぽの保険料は 2006 年医療制度改革法を経て、都道府県単位の支部ごとに保険料が設定されることになっており、料率の変化は支部ごとに異なる。

²⁸ 多くの市町村では「滞納の時効が長い」などの理由で、「国民健康保険税」が採用されているが、ここでは「保険料」の表記で統一する。

一方、負担と受益を都道府県単位で明確にする観点に立ち、国民健康保険の保険料水準を都道府県単位で統一する見直しが段階的に図られているが、保険料の賦課方式が市町村ごとに違うなどの事情で、一気に進めるのは困難である²⁹。こうした中、今回の制度改革では保険料水準の統一などの際、保険料が著しく上昇する場合、従来の3年よりも長い期間での返済が可能になった。

併せて、医師や弁護士など職種別に設置されている国民健康保険組合に関する国庫補助も見直されることが決まった。すなわち、国民健康保険組合の医療給付費に関する国庫補助率は一般組合員の平均所得に応じて変動する仕組みになっており、現在は13%から32%まで11段階に分かれている。今回の見直しでは、財政力が豊かな国民健康保険組合に関して、「12%」「10%」という新たな補助率の区分が特例的に創設されることになった。

3 | 医療機関の生産性向上支援に関する見直し

最後に、医療機関の生産性向上支援に関する見直しを取り上げる。これは都道府県単位で設置されている「地域医療介護総合確保基金」について、医療機関の業務効率化・勤務環境改善を支援するための新たな類型が創設されることが柱。

ここで言う地域医療介護総合確保基金は2014年度に創設された仕組みであり、消費税の増税分の一部が充当されている。これまでの類型では、▽急性期機能の重点化などを図る「地域医療構想」の推進に向けた医療機関の施設・設備整備や病床削減、▽在宅医療の充実、▽医療従事者の確保、▽介護事業所の設備整備、▽介護従事者の確保、▽勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備——などに充てられている。

今回の見直しでは、デジタル機器の導入などを通じて業務効率化や勤務環境改善の取り組みを支援する新たな類型が創設された。この関係では、生産性向上に取り組む医療機関のデジタル機器の導入などを支援する事業が2024年度補正予算と2025年度補正予算で計上されており、地域医療介護総合確保基金の事業に位置付けることで、恒久化させる狙いがある³⁰。

さらに、▽業務効率化や勤務環境改善に取り組む病院を厚生労働省が認定・表彰できる規定の追加、▽医療機関の労務管理を目的にした都道府県単位の「医療勤務環境改善支援センター」の業務として、医療機関の業務効率化に関する助言・指導を明確化、▽健康保険法に基づく保険医療機関の努力義務として、業務効率化や勤務環境の改善を条文に追加——といった見直しが講じられた。

以上、2026年特別国会で成立した医療保険制度改革法の主な内容を概観した。上記を振り返ると、高額療養費の見直しや出産費用の保険適用は以前からの「宿題」だったのに対し、自民、維新の連立政権の発足後、全体として給付抑制の傾向が強まった結果、OTC類似薬の見直しが浮上した経過を確認できる。

²⁹ ここでは詳しく触れないが、国民健康保険の財政運営については、2018年度以降、市町村から都道府県の責任に変わり、都道府県単位の保険料水準の統一化が図られている。具体的には、市町村が都道府県に支払う「納付金ベース」の統一と、「同じ所得水準、同じ世帯構成であれば、都道府県内のどこに住んでも同じ保険料の水準」を目指す「完全統一」の2つがあり、前者を2026年度、後者を2035年度をメドに実現することが目標に定められている。国民健康保険の都道府県化や保険料水準の統一に関しては、2023年8月25日拙稿「[全世代社会保障法の成立で何が変わるのか（下）](#)」、2018年4月11日拙稿「[国保の都道府県化で何が変わるのか（上）](#)」（全3回、リンク先は第1回）を参照。

³⁰ 2025年度補正予算の内容などに関しては、2025年12月23日「[補正予算に計上された『医療・介護等支援パッケージ』を読み解く](#)」を参照。

特に、筆者自身は OTC 類似薬見直しの決着については、今後の連立政権の動向を見ていく際の重要な素材になると見ている。以下、維新の連立入り前に交わされた 2025 年 6 月の 3 党合意とか、2026 年 7 月に交わされた社会保障改革に関する自民、維新の「社会保障改革項目に関する具体的な骨子」（以下、骨子）も含めて、医療制度改革という文脈で両党の関係性や今後の論点を改めて検討する。

8——今後の見直し論議の展望

1 | 自民、維新連立の典型例に？

まず、医療政策に関する両党の関係性を概観する。そもそも、医療政策に関する維新のスタンスは給付抑制を基調としており、先に触れた通り、2025 年 2 月に公表された「社会保険料を下げる改革案（たたき台）」では、OTC 類似薬や高齢者の患者負担割合の見直しなどが掲げられていた。

しかし、2025 年通常国会で高額療養費の見直し論議が頓挫した通り、医療費抑制には様々な利害が絡むため、一気呵成の見直しは困難である。その結果、現実的な解決策に落ち着かざるを得ず、維新が望むような急進的な「改革」は難しいと言わざるを得ない。それでも維新としては、少しでも給付抑制を進めることで、与党入りのメリットを強調する誘因が働く。

こうした状況の下、両者の見直し論議は「維新が『改革』をアピールするため、ラディカルな案を提示→政府・自民党との調整を経て、実現可能な線で決着→維新は『改革の第一歩』と成果を強調」という構図で推移しやすくなっている。

実際、OTC 類似薬の見直しに際して、維新は 1 兆円程度の医療費を削減できると主張したが、現実には副作用が大きい薬も含まれており、リスクを勘案すると、対象は限定的とならざるを得なかった。維新が主張した保険の適用から外す案についても、最終的には患者団体の意見を考慮する必要に迫られた結果、「特別の料金」を課す形で落ち着いた。

こうした過程で維新の関係者の SNS などでは、見直しに否定的な日医を「抵抗勢力」のように位置付ける言説が散見された³¹が、患者の負担を増やす点では、直前に是非が争点となった高額療養費の見直しと同じであり、与党全体としては「第 2 の高額療養費」になることを恐れる意見が勝った³²。言い換えると、政府・自民党から見れば妥当な線に落ち着いたものの、維新から見ると微温的な改革になった面は否めない。

それでも OTC 類似薬は過去、何度も見直し論議が浮上したにもかかわらず、日医の反対などで実現しなかった経緯があるため、維新としては「我々が求めた水準からすると小さな一歩」「新たな制度を

³¹ 確かに過去の経緯を振り返ると、日医が OTC 類似薬の見直しに反対を貫いていたため、見直しは限定的となっていた。例えば、予算の削減や透明化を図るため、民主党政権期の 2009 年 11 月に実施された「事業仕分け」で話題になったが、大きな見直しには至らなかった。その後、保険給付の適正化の名目で、2012 年度から栄養補給目的でのビタミン剤投与が保険給付の対象から外れたほか、2014 年度に治療目的でないが、2018 年度に疾病の治療以外を目的とした保湿剤についても、同様の扱いが取られることになった。さらに、2016 年 11 月の財政制度等審議会（財務相の諮問機関、以下は財政審）の建議（提言）でも、「市販薬市販品と同一の有効成分の薬でも、医療機関で処方されれば、市販品を購入するよりも低い自己負担で購入できる」として、長らく市販品として定着している医療用医薬品については、保険給付から外すなどの見直しが必要との見解が示された。今回の見直し論議でも、▽患者・家族の経済的、物理的な負担増、▽薬へのアクセス悪化の懸念、▽重篤な疾患の早期発見・早期治療の機会喪失——などを理由に、日医は OTC 類似薬を保険適用外とすることに反対していた。2026 年 1 月 20 日、2025 年 9 月 5 日『日医ニュース』などを参照。

³² 2025 年 12 月 25 日『毎日新聞』を参照。

つくり、社会保険料を下げる動きに向けた風穴をあけるような画期的な合意」³³という説明が可能になった。

上記の展開は他の医療制度改革でも見受けられる。具体的には、2025年6月の3党合意に際して、維新は医療提供体制改革の加速を通じて、「約11万床」「約1兆円」の削減を迫った。結局、維新が「約11万床」の削減を「目標」と理解する一方、自民が「目安」程度と受け止めるなど、いわゆる「玉虫色」の決着となったものの、「約11万床」という3党合意の数字は政府文書に使われるようになった³⁴。

つまり、約11万床は明確に「目標」として設定されているわけではないが、維新の主張が政府の方針に反映されているのは間違いなく、維新としては「従来の政府の取り組みよりも、一步も二歩も踏み込んだ書き方で載せることで合意を得ました」³⁵と強調できる余地が作られている。

以上のようなケースを重ね合わせると、いずれも「維新が『改革』をアピールするため、ラディカルな案を提示→政府・自民党との調整を経て、実現可能な線で決着→維新は『改革の第一歩』と成果を強調」という構図で推移していることに気付かされる。

しかも、この構図は2026年7月に策定された骨子にも共通している。以下、骨子に盛り込まれた案件のうち、(1)高齢者患者負担の見直し、(2)医療費の伸びをGDPや経済成長率などと連動させる抑制目標の設定（いわゆる医療版マクロ経済スライド）——という2つについて、両党の調整過程を考える³⁶。

2 | 自民、維新の協議体での意見調整(1)～高齢者患者負担の見直し～

骨子の検討は2025年10月の連立合意に盛り込まれた13項目³⁷に沿って、2026年3月以降、両党の実務者で構成する与党社会保障制度改革協議体を中心に進んだ。特に、意見が割れたのは「高齢者の患者負担引き上げ」「社会保障負担率を経済成長の範囲内に抑えるなど数値目標の設定」の2つである。

このうち、前者では図表6の通り、原則として70歳以上高齢者の患者負担が1～2割にとどまって

³³ 2025年12月19日の記者会見における維新の斎藤アレックス政調会長による発言。同日配信記事『朝日新聞デジタル』

³⁴ 3党合意では、医療提供体制改革の加速なども盛り込まれていた。詳細については、2026年2月27日拙稿『臨時国会で成立した改正医療法で何が変わるのか(中)』を参照。

³⁵ 2025年6月20日『m3.com』配信記事における阿部圭史衆院議員に対するインタビューを参照。

³⁶ 政局的な解説は本稿の対象を超えているが、維新がドラスティックな改革を自民党に迫る状況は医療制度改革以外の分野でも散見される。例えば、首都圏のバックアップを目指す「副首都」に関する法律の整備や議員定数の削減などでも、維新は「改革政党」であることをアピールするため、自らの主張を自民党に強く要望する場面が目立った。維新は発足後、既成政党を批判しつつ、大阪府・大阪市の一体化を図る「大阪都構想」を含めた「改革」の必要性を掲げてきた経緯があり、「改革」の看板を掲げ続けることが存在理由となっている形だ。維新の歴史や主張の系譜などについては、塩田潮（2021）『解剖 日本維新の会』平凡社新書などを参照。

³⁷ ここで言う13項目とは、(1)現役世代の保険料負担抑制との整合性を図るための制度的な対応を含めた保険財政の健全化策推進、(2)医療介護分野での保険者の権限・機能の強化、都道府県の役割強化、(3)病院機能の強化、創薬機能の強化、患者の声の反映およびデータに基づく制度設計のための中央社会保険医療協議会の改革、(4)年齢に依らない患者負担の応能負担の実現、(5)年齢と関係なく働き続けられる社会のため「高齢者」の定義見直し、(6)人口減少下でも地方の医療介護サービスを持続的に提供するための制度設計、(7)国民皆保険制度を守るための公的保険の在り方および民間保険の活用に関する検討、(8)大学病院機能の強化、(9)診療報酬の抜本的な見直しによる高度機能医療病院の経営安定化と従事者の処遇改善、(10)配偶者の社会保険加入や生涯非婚率の上昇なども踏まえた第3号被保険者制度の見直し、(11)医療の費用対効果分析に関する指標の確立、(12)医療機関の収益構造の増強、経営安定化に向けた営利事業の見直し、(13)医療機関の高度医療機器や設備更新などに関する消費税負担の在り方を見直し——など。

いるため、現役世代の負担軽減を重視する維新が原則3割を主張。これに対し、「高齢者は現役世代と比べて通院回数が多い」などを理由に、自民党が難色を示した。

結局、骨子では「原則3割負担」という言葉は入らず、「低所得者等の必要な受診が確保されるよう適切に配慮することを前提として、原則3割となっている現役世代との間で年齢によらない真に公平な応能負担を実現する観点から見直し

図表6：患者負担のイメージ

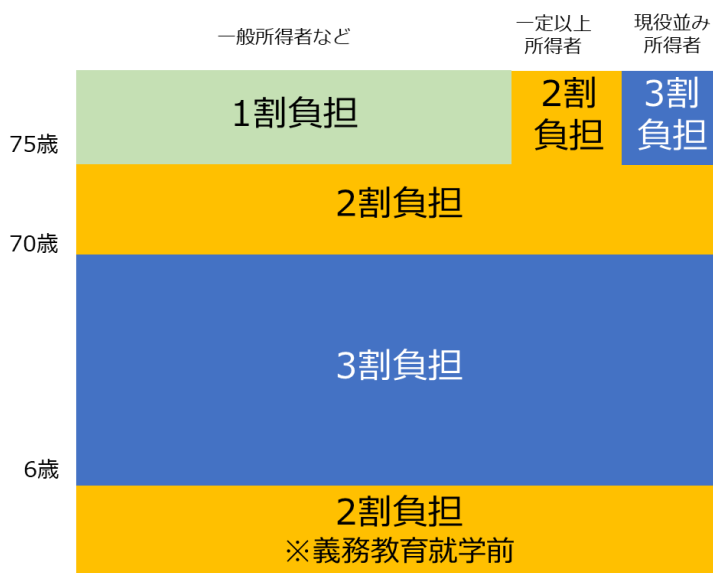
を行う」とし、改革工程表を2026年12月までに作る方針が盛り込まれた。

この文章で両党の意見が折衷されたのは明らかであろう。つまり、「低所得者等の必要な受診が確保されるよう適切に配慮」は患者負担引き上げに慎重な考え方であり、自民党のアイデアが反映されていると理解できる。

一方、後段の「原則3割となっている現役世代との間で年齢によらない真に公平な応能負担を実現する観点」は維新の主張に考慮し、患者負担増に積極的な文言と読み取れる。言い換える

と、両党の意見の差は解消し切れておらず、2026年12月までに作られる改革工程表まで結論を持ち越したことになる。

それでも維新からは「日本の社会保障政策、医療保険政策の大きな転換点になる合意」³⁸との声が出ており、「維新が『改革』をアピールするため、ラディカルな案を提示→政府・自民党との調整を経て、実現可能な線で決着→維新は『改革の第一歩』と成果を強調」というパターンが継続されていることを確認できる。



出典：厚生労働省資料を基に作成

3 | 自民、維新の協議体での意見調整(2)～抑制目標の設定～

もう1つの社会保障の負担率や医療費の伸び率を経済成長の範囲内に抑制する目標を設定する案についても、自民、維新の協議で焦点になった。

つまり、保険料抑制を重視する維新が医療費の伸びをGDPの範囲内などに抑える数値目標の設定（いわゆる医療版マクロ経済スライド）を強く望んだのに対し、医療の高度化に対応できなくなるという理由で、自民は消極姿勢を崩さなかった。結局、両論を併記するような形で、下記の文言が骨子に盛り込まれるに至った。

経済・物価動向等に適切に対応し、安心して医療・介護・福祉サービスを受けられる体制を整備することとあわせて、医療・介護を中心とした社会保障制度改革を着実に実行することにより、現役世代の保険

³⁸ 2026年7月7日に開かれた維新の斎藤政調会長による発言。同日配信「日本維新の会 YouTube」を参照。

料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指す。このため、骨太方針 2025 と同様、経済・物価動向等を踏まえ、的確な対応を行いつつ、これまでの歳出改革努力を継続し、2027 年度の社会保障負担率が 2025 年度と比較して上昇しないよう取り組む。

また、社会保障制度が果たす機能を損なわないよう配慮しつつ、社会保障負担率の目標の検討を進め、これとあわせて、社会保障改革について 2026 年度中に改革項目の具体化と工程の明確化を図り、順次実施する。

特に、高齢化や高度化等への対応が必要な医療給付費については、経済が成長し賃上げが継続する「強い経済」の構築に向けた取組を進める中で、診療報酬に経済・物価動向等を基本的に反映しつつも、医療給付費の対 GDP 比や雇用者報酬の伸びとの関係などを参照しつつ、医療費適正化計画の次期改定に向けて抜本的な見直しを行うことを含め、改革を継続する。

まず、1 つ目の段落のうち、「経済・物価動向等に適切に対応し、安心して医療・介護・福祉サービスを受けられる体制を整備」「骨太方針 2025 と同様、経済・物価動向等を踏まえ、的確な対応」という部分は物価上昇に対応する形で、診療報酬や介護報酬を引き上げる方向性と読み取れる。これは明らかに自民党の主張に配慮した文言である。

これに対し、「医療・介護を中心とした社会保障制度改革を着実に実行することにより、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていく」という部分では維新の主張が反映されており、やはり両党の意見が折衷された上で、2027 年度の社会保障負担率が大幅に上昇しないような歳出改革を継続する方向性が示されている。

2 つ目の段落も同じような構造で作られており、「社会保障制度が果たす機能を損なわないよう配慮」は歳出改革に慎重な意見、逆に「社会保障負担率の目標の検討」は給付抑制に積極的な意見が反映されており、2026 年度中に改革項目の具体化と方向性を明確にすると書かれている。つまり、ここでも両論が併記された上で、2027 年 3 月までに改革項目と方向性を明確にする旨が盛り込まれており、結論を持ち越した形となっている。

このほか、最後の段落では、両者の意見対立が顕著に表れている。すなわち、「診療報酬に経済・物価動向等を基本的に反映」では診療報酬を引き上げる方向性が示されているのに対し、「医療給付費の対 GDP 比や雇用者報酬の伸びとの関係などを参照」という部分は GDP や現役世代の給与と連動させて医療費を抑えるマクロ経済スライドに近い発想が盛り込まれており、やはり両論が併記されている。

何よりも最後の段落では「～しつつ」という言葉が連続かつ重複して使われており、日本語として不自然な構成になっている。この辺りを見ると、現役世代の負担軽減と医療費抑制を重視する維新と、ドラスティックな見直しに慎重な姿勢を示した自民との間で、調整が難航した形跡を読み取れる。

最後の文章で言及されている「医療費適正化計画」の文言も要注目である。ここで言う医療費適正化計画³⁹とは、医療提供体制改革や健康づくりなど、医療費の抑制に向けた方策を国と都道府県が 6 年

³⁹ 元々、医療費適正化計画の仕組みが 2006 年医療制度改革で創設されたのも、医療版マクロ経済スライドの是非が話題になったためだった。この時、医療費をマクロでコントロールする必要性が経済財政諮問会議で提起されたが、現場への悪影響などを恐れる厚生労働省は難色を示した。結局、医療費適正化計画の仕組みが制度化されるとともに、その手段として 40 歳以上 75 歳未満の人を対象に生活習慣病対策を強化する「特定健康診査・保健指導」が位置付けられた。しかし、「生活習慣病を予防→入院医療費を適正化→医療費を適正化」というロジックには無理があり、財務省は見直しを要求している。医

周期で定める計画を指す。

今回の骨子では「次期改定に向けて抜本的な見直し」という文言が入っており、抑制的な目標を設定する方向性とか、目標実現に向けた実効性を担保する方針が示されたかのようにも読める。

一方、現在の計画は2029年度まで続くため、改定に向けた議論が始まる2027～2028年頃まで結論が先送りされたと見ることもできる。

さらに、医療費の抑制目標に関しても、具体的な数字が示されているわけでもないし、「抜本的な見直し」についても、何の内容も盛り込まれてない。何よりも「抜本的な見直し」の後ろには「含め」という言葉が挿入されており、「抜本改革」とは言えないような見直しが講じられる可能性まで示唆されている。要するに、メディアが好む表現を使うとすると、全体として「玉虫色」の表現が随所に使われていると言える。

それにもかかわらず、維新からは「(筆者注：経済成長率や雇用報酬などの)指標を参照しながら、(筆者注：医療費などを)引き下げていくことも読める内容」「新しい政策運営の考え方を導入する第一歩になった」⁴⁰という総括が出ており、ここでも「維新が『改革』をアピールするため、ラディカルな案を提示→政府・自民党との調整を経て、実現可能な線で決着→維新は『改革の第一歩』と成果を強調」という流れを確認できる。

4 | 骨太方針の表記

こうした「玉虫色」の表記は2026年7月に閣議決定された骨太方針にも反映されたので、▽物価上昇への対応、▽高齢者の患者負担引き上げ、▽抑制目標の設定(いわゆる医療版マクロ経済スライド)——に関わる部分を抽出し、2027年度予算編成に向けた論点を簡単に検討する。

まず、物価上昇への対応では、「医療・介護・保育・福祉等の公定価格について、現場の人材確保、経営の安定、サービスの質の確保に必要な対応を進める」「経済・物価の動向が2026年度診療報酬改定時の見通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には、2027年度予算編成過程で診療報酬上の加減算を含む更なる必要な調整を行う」「次期介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定では、経営データベースの整備・活用を含め、2026年度診療報酬改定における各般の取組を参考にしつつ、介護・障害福祉分野の賃上げの状況や介護・障害福祉サービス等事業者の経営状況等を把握した上で、補装具費支給基準額も含め、物価の変動に適切に対応するとともに、他職種と遜色のない処遇改善の実現を図る」という文言が盛り込まれており、インフレ基調に対応して公定価格を引き上げる内容とも読める。

このうち、診療報酬は2026年6月に始まった新体系の下、2026年度～2027年度の2段階で引き上げることで、賃上げや物価対応が考慮された。しかし、2027年度への対応に関しては、経済動向を見つつ、加減算を検討するとしており、こうした方向性が骨太方針でも改めて確認された形だ⁴¹。

一方、介護報酬に関しては、3年に一度の見直しが2027年度に控えており、今回の骨太方針では昨

療費適正化計画の創設に至る経緯や論点、見直しの動向などについては、2023年8月25日拙稿「[全世代社会保障法の成立で何が変わるのか\(下\)](#)」を参照。

⁴⁰ 2026年7月7日に開かれた維新の斎藤政調会長による発言。同日配信「日本維新の会 YouTube」を参照。

⁴¹ 2026年度診療報酬改定のうち、賃上げや物価対応については、2026年6月22日拙稿「[2026年度診療報酬改定を読み解く\(上\)](#)」を参照。

年にも使われていた「他職種と遜色のない処遇改善」というフレーズが踏襲された⁴²。今後、引き上げ幅や方法などが2027年度予算編成の焦点となりそうだ。

2点目の高齢者患者負担に関しては、骨太方針では骨子の内容に沿って、「医療保険制度では、70歳以上の高齢者の医療費窓口負担割合について、低所得者等の必要な受診が確保されるよう適切に配慮することを前提として、原則3割となっている現役世代との間で年齢によらない真に公平な応能負担を実現する観点から見直しを行う。そのための改革工程表を2026年末までに策定する」という文言が入っており、今後の政府・与党の調整を注視する必要がある。

3つ目の抑制目標の設定についても、今後の調整事項となる。ここで、注目は骨子からの文言の変化である。つまり、骨太方針では先に引用した骨子の文章のうち、「経済・物価動向等に適切に対応し……」という文言がほぼ踏襲されている反面、「特に、高齢化や高度化等への対応が必要な……」という一文が丸ごと抜けている。

しかも、この一文では、成長率や雇用報酬との連動とか、医療費適正化計画の抜本的な見直しが具体的に書かれていたことを考えると、反対意見に考慮する形で、政府・与党内の調整で記述が回避されたのではないだろうか。実際、抑制目標の目標を検討する方向性について、日医は「到底容認できない」⁴³と反対しており、調整の難航を予想させる展開となっている。

5 | 「3割負担」堅持との関係性

今後の論点として、筆者自身は「一部保険外療養を含めて、保険外療養費制度の枠組みがなし崩し的に広がるのではないか」という点が気になっている。特に最近の医療制度の見直し論議では、患者負担の在り方や公的医療保険のカバー範囲など「そもそも論」が検討されないまま、首相官邸の意向や連立与党の結論が優先されることが多い。その結果、往々にして見直し論議は「実施ありき」で進み、最終局面で落としどころを探す展開になっている。

こうした漸増主義的な意思決定が続く状況では、確実に制度を変えられるメリットがある反面、「政治的に手を付けやすい部分から見直す」という判断が優先され、既に制度化されている一部保険外療養や選定療養の対象が広がる可能性が想定される。

さらに、「3割負担」の堅持を定めた2002年医療制度改革法との関係性も意識する必要がある。この時の制度改革は約5年に及んだ小泉純一郎政権で実施された最初的大幅な医療制度改革であり、検討過程では健康保険組合など被用者保険の患者負担を2割から3割に引き上げる是非を巡り、政府と与党が激しく対立した。最終的に、小泉首相が強く望んだ3割負担は実現されたが、改正健康保険法の附則第2条で「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする」という規定が入った。

ここで注目されるのは附則の位置付けである。当時の経緯を知る厚生労働省の官僚OBは患者負担を巡る座談会で、「(筆者注：附則を)『書け』と言った人たちは、『3割はけしからん。これ以上は絶対

⁴² 2025年6月の骨太方針に関する介護関係の文言などについては、2025年6月24日拙稿「[医療機関の経営危機、報酬改定と予算編成はどうなる？](#)」を参照。

⁴³ 2026年7月22日に開かれた日医の松本吉郎会長の記者会見における発言。同月23日『ミクス on-line』配信記事を参照。

にダメだぞ』という意味で言っていました」⁴⁴と振り返っており、一層の患者負担引き上げの歯止めとして作られたのは間違いない。つまり、小泉氏の強い意向で導入された3割負担に対し、自民党の反対派がクギを刺すために入れた文言と理解できる。

実際、当時は自民党内の反対派から『首相の人気によって国民が痛みを我慢してくれる今のうちに、取りやすいところから取る仕組みにしておこう』という発想にしか思えない⁴⁵という意見が強く示されており、「3割負担堅持」の附則は将来の見直し論議も拘束する「防波堤」「ストッパー」の側面を持っている。

一方、逆に給付を抑制したい側から見ると、附則は見直し論議の「足枷」「障壁」になっている。かと言って、「3割負担」の堅持を掲げた附則の見直しは政治的なハレーションを巻き起こす。その結果、「手を付けやすい改革」として、選定療養の対象が広がったり、一部保険外療養の仕組みが作られたりしている面がある。

実際、患者負担に関する厚生労働省 OB による座談会では、紹介状なし大病院受診を念頭に入れつつ、「今の選定療養は無原則に広げ過ぎていますよね。やむを得ずに入院するのがなぜ選定なのか」との声が出ていた⁴⁶。さらに、社会保障法学の研究でも「法律上の定めがあまりにも抽象的」と指摘されている⁴⁷。

近年の動きとしても、選定療養の対象となり得る経費について、厚生労働省が2023年度から意見を一般募集し始めた⁴⁸ほか、財務省が2026年4月の財政審で、「窓口業務は診療行為そのものではなく、そもそも診療報酬で評価される必然性はない」として、窓口業務を保険外に位置付けるように要請するなど、選定療養や一部保険外療養を広げるような動きが相次いでいる。これらの事象についても、「3割負担堅持」を定めた附則を「補助線」として考えると、附則に手を付けないまま、保険給付を圧縮する動きと理解できる。

もちろん、医療保険財政は厳しい状況であり、現役世代の保険料負担軽減も重要なテーマである。このため、制度改正の選択肢として、患者負担の引き上げの可能性を全否定することは困難と言わざるを得ない。しかも、保険診療から支出された費用を示す国民医療費で見ると、2023年度現在の患者負担の割合は11.8%であり、「3割」を遥かに下回っていることを考えると、3割負担堅持との整合性を問うのは時期尚早と言えるかもしれない。

しかし、漸増主義的な改革が積み上げられている中、「附則を見直しにくいので、政治的に手を付けやすい選定療養や一部保険外療養を広げる」という選択肢が取られる可能性は十分に想定される。こうした迂回的な方法は分かりにくく、制度を複雑にするリスクもある。今後は医療保険財政の現状も

⁴⁴ 医療科学研究所監修（2022）『徹底研究 医療費の患者負担の在り方』医療科学研究所 p231 における中村秀一・元厚生労働省社会・援護局長による発言。

⁴⁵ 2002年2月11日『朝日新聞』を参照。

⁴⁶ 医療科学研究所監修（2022）『徹底研究 医療費の患者負担の在り方』医療科学研究所 p244 における堤修三・元社会保険庁長官による発言。

⁴⁷ 笠木映里（2024）「選定療養をめぐる最近の動向と論点」『健康保険』2024年10月号を参照。

⁴⁸ 2026年度診療報酬改定では「療養の給付と直接関係ないサービス」として、「予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料」「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料（診察日の直前にキャンセルした場合）」「Wi-Fi 利用料」「在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用（通訳の手配料や翻訳機の使用料など）」について、医療機関が患者に対して選定療養として料金を追加的に請求することが明確化された。ただ、「全ての医療機関でキャンセル料が徴収される」という情報が SNS などでも流れたため、厚生労働省が追加的に説明する状況となった。

勘案しつつ、患者負担の在り方を議論するような工夫も必要と考えられる。

6 | 高齢者の患者負担の方向性は？

最後に、高齢者の患者負担の在り方について、筆者の意見を簡単に記す⁴⁹。まず、年齢で一律に区分する今の仕組みは合理的とは言えず、筆者自身は「1973 年から約 10 年間、実施された老人医療費無料化に始まる歴史的な経緯でしか説明できない」と考えている。むしろ、「医療サービスを真に必要としている患者の負担を増やす高額療養費の上限引き上げよりも、合理的とは言えない年齢区分の仕組みの見直しを先行させる必要があった」という認識である。

確かに現役世代と比べると、一般的に高齢者の収入は低く、受診回数も多いため、配慮が必要であるが、その方法が一律の年齢区分とは思えない。このため、高額療養費の特例などを通じて、高齢者の患者負担を現役世代よりも抑える配慮を講じつつ、将来的には「こどもを除く患者負担は 3 割で統一」を目指す対応が必要と考えている。

さらに、上記の見直しを進める際には高齢者の暮らしに考慮するため、一定程度の周知期間や経過措置を設けるのは当然であり、見直しの歩みが漸増主義的になるのは止むを得ない。

9—おわりに

本稿では、2026 年特別国会で成立した医療保険制度改革法の内容を概観した。このうち、OTC 類似薬の見直しの関連では、自民と維新の利害調整も含めて、一部保険外療養として「特別の料金」が課された経緯を振り返るとともに、その意味合いを検討した。今後、「特別の料金」を課さない対象などを決める技術的検討会の議論とともに、一部保険外療養の対象がなし崩し的に広がるかどうか、その行方を注視する必要がある。

さらに、高額療養費の見直しについても、当初の案が事実上の白紙撤回となった経緯に触れつつ、上限を抑えるなどの配慮が講じられた結果、2025 年通常国会の審議と比べると、全体として「無風」となった背景なども検討した。このほか、出産費用の保険適用に関しても、浮上した経緯や論点なども考察した。

その上で、医療費適正化に関わる自民、維新の政策協議について、2026 年 7 月に作られた骨子の文言を細かく検証した。今後も医療費の伸びを経済成長率などに連動させる案とか、高齢者の患者負担に関して、両党の調整は難航する可能性が高い。

このほか、「政治的に手を付けやすい選定療養や一部保険外療養を広げる」という漸増主義的な改革が積み上げられると、「3 割負担堅持」を掲げた 2002 年改正健康保険法の附則との整合性が問われる可能性もある。こうした迂回的な方法だけではなく、医療保険財政の現状も踏まえつつ、患者負担の在り方を議論する機会や場が必要と考えられる。

⁴⁹ 高齢者の患者負担に関する経緯については、2022 年 1 月 12 日拙稿「[10 月に予定されている高齢者の患者負担増を考える](#)」、2020 年 12 月 22 日拙稿「[後期高齢者の医療費負担はどう変わるのか](#)」、2020 年 2 月 25 日拙稿「[高齢者医療費自己負担 2 割の行方を占う](#)」を参照。

参考資料：一部保険外療養で「特別の料金」が課される予定の77成分（1）

No	有効成分	用途	No	有効成分	用途
1	アシクロビル	抗ウイルス薬	21	クロラムフェニコール	抗生物質
2	アシタザノラスト水和物	抗アレルギー薬	22	クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾン	抗生物質
3	アスコルビン酸	ビタミン剤	23	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
4	アンモニア水	鎮痛鎮痒収斂消炎剤	24	ケトチフェンフマル酸塩	抗アレルギー薬
5	イソコナゾール硝酸塩	抗真菌薬	25	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	総合感冒剤
6	イソプロパノール	殺菌消毒剤	26	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤
7	イトブリド塩酸塩	胃薬	27	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	鎮痛消炎剤
8	イブプロフェン	非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)	28	サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル	鎮痛消炎剤
9	イブプロフェンピコノール	非ステロイド系消炎鎮痛剤	29	サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル・グリチルレチン酸	鎮痛消炎剤
10	インドメタシン	鎮痛消炎剤	30	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
11	エタノール	殺菌消毒剤	31	酸化亜鉛	収れん・消炎・保護剤
12	エピナスチン塩酸塩	抗アレルギー薬	32	次亜塩素酸ナトリウム	殺菌消毒剤
13	Ｌ-カルボシステイン	去痰薬	33	ジクロフェナクナトリウム	非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)
14	塩酸テトラヒドロソリン・プレドニゾン	点鼻用血管収縮剤	34	消毒用エタノール	殺菌消毒剤
15	オキシコナゾール硝酸塩	抗真菌薬	35	静脈血管薬エキス	痔治療薬
16	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤	36	精製水	溶解剤
17	オキシドール	殺菌消毒剤	37	炭酸水素ナトリウム	胃腸薬
18	オリブ油	皮膚保護剤	38	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	カルシウム配合剤
19	希ヨードチンキ	殺菌消毒剤	39	チンク油	消炎薬
20	クロトリマゾール	抗真菌薬	40	デキサメタゾン	ステロイド

出典：厚生労働省資料を基に作成

参考資料：一部保険外療養で「特別の料金」が課される予定の77成分（2）

No	有効成分	用途	No	有効成分	用途
41	テルビナフィン塩酸塩	抗真菌薬	61	ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	ステロイド
42	トコフェロール酢酸エステル	ビタミン剤	62	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
43	トリアムシノロンアセトニド	口内炎・舌炎薬	63	ベボタスチンベシル酸塩	抗アレルギー薬
44	尿素	皮膚軟化剤	64	ベミロラストカリウム	抗アレルギー薬
45	白色ワセリン	軟膏基剤	65	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	止瀉剤
46	ハチミツ	矯味剤	66	ベンザルコニウム塩化物	殺菌消毒剤
47	ピコスルファートナトリウム水和物	緩下剤	67	ホウ砂	眼科用剤
48	ピサコジル	便秘薬	68	ホウ酸	眼洗浄・消毒薬
49	ビダラビン	抗ウイルス薬	69	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
50	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	ステロイド	70	ポリエンホスファチジルコリン	高脂血症薬
51	フェキソフェナジン塩酸塩	抗アレルギー薬	71	マルツエキス	乳幼児用便秘薬
52	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	抗アレルギー薬	72	ミコナゾール硝酸塩	抗真菌薬
53	フェルピナク	非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)	73	無水エタノール	殺菌消毒剤
54	ブテナフィン塩酸塩	抗真菌薬	74	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	アレルギー性鼻炎治療薬
55	複方ヨード・グリセリン	口腔用殺菌消毒剤	75	ヨウ素	殺菌消毒剤
56	ブドウ酒	滋養強壮薬	76	ロキソプロフェンナトリウム水和物	解熱消炎鎮痛剤
57	フラボキサート塩酸塩	頻尿・残尿感薬	77	ロラタジン	抗アレルギー薬
58	フルチカゾンプロピオン酸エステル	ステロイド			
59	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	ステロイド			
60	ベタメタゾン吉草酸エステル	ステロイド			

出典：厚生労働省資料を基に作成

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。
また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。